EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 88418
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-07-13 08:52:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JUAN PASCUAL RIQUELME FUENTES			RUN	: 4.829.567-3
F.Nac	: 08-01-1943	Edad	: 81 AÑOS, 6 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: BALMACEDA 01			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 82791131		
Fecha Ingreso	: 2024-06-24	Fecha Egreso	: 2024-07-13 08:52:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Shock Séptico P/P Respiratorio Resuelto
2. Insuficiencia Respiratoria Aguda Recuperada
2.1.Neumonía Adquirida En La Comunidad
2.2. Enfermedad Pulmonar Intersticial Vs Neumonitis Por Hipersensibilidad
3. Lesión Renal Aguda KDIGO I Recuperada
4. Delirium Mixto
5. HTA
6. DM2 ?

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. J00-J06-INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. E87.0-HIPEROSMOLARIDAD E HIPERNATREMIA. (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. E10-E14-DIABETES MALLITUS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes de HTA y neumonitis por hipersensibilidad, en controles poli broncopulmonar HCHM. Consulta en SU HSC 24/06/24 por cuadro clínico de dos días de evolución caracterizado por compromiso del estado general, episodios febriles, aumento de disnea y tos productiva. Ingresó a SU HSC en malas condiciones generales, con síntomas de insuficiencia respiratoria aguda, se solicitaron exámenes donde destacó GSA pH 7.39, pO2 107, pCO2 22, HCO3 13.5, FiO2 95%, PaFi 114, PCR 321. Además, se solicitó angioTAC de tórax donde se evidenció enfermedad fibroenfisematosa difusa con áreas de panalización, sugerentes de patrón tipo UIP, infiltrados con tendencia a la consolidación de aspecto predominante intersticial, además arteria pulmonar en el límite superior de la normalidad, considerar hipertensión pulmonar. Se solicitaron cultivos, parámetros inflamatorios elevados, PCR 321. Se inició tratamiento ATB biasociado con ceftriaxona y azitromicina, se realizaron NBZ y se decide conexión a VMNI con buena respuesta clínica y gasométrica. Evaluado por Residente UTI, se decide ingreso a unidad para continuar monitorización y manejo. Paciente evoluciona con hemodinamia estable, autosostenida, sin requerimiento de DVA. Función renal conservada, sin trastorno HE. Metabólicamente hiperglicemico sin necesidad de refuerzo con IC. Afebril, bajo cobertura antibiótica, parámetros inflamatorios en descenso. Se logra toma de muestra CSB 27/06/24 con aspecto purulento con estrias de sangre. Desde el punto de vista ventilatorio, se apoya con VMNI desde el ingreso, con posterior conexión a CNAF con regular tolerancia, el 26/06/24 se apoya inicialmente con morfina, por empeoramiento gasométrico y de mecánica ventilatoria, se inicia BIC de precedex y se conecta nuevamente VMNI.

GSA control am 27/06/24 Ph 7.36, PCO2 38, PO2 65, HCO3 22, FiO2 50%. Paciente persiste con mala mecánica ventilatoria, se toman nuevos GSA de control Ph 7.46, PCO2 31, PO2 60, HCO3 22, FiO2 50%. Se presenta caso a UCI, se acepta traslado. Por desaturación sostenida, residente UCI se decide IOT en la unidad, Tubo 8.5 a 21 cm (Fentanyl 100 ug, Etomidato 20 mg, Atracurio 50 mg)
Se mantuvo 7 días en VMI, con prono primera 72 hrs, se superficializa sedación con salida a VMNI, actualmente con naricera 1 litro
En UCI se escala tto ATB a tazonam y se mantiene azitromicina hasta rescatar cultivos, los cuales resultan negativos, por lo que se desescala a ceftriaxona , actualmente sin conflicto inflamatorio
Evaluado por fonoaudiología el día 06.07.24, se indica retiro SNG y reinicia de alimentación papilla
Ingresa para continuar rehabilitación
En UTI se mantiene estable, se desteta de oxígeno durante el día 08.07 en la mañana, permanece con miopatía de paciente crítico, en rehabilitación con KNT.
Reevaluado por fonoaudiología con deglución eficaz, por lo que se da de alta fonoaudiológica.
Actualmente en buenas condiciones generales, afebril, ventilando espontáneo, en condiciones de egreso a sala medicina interna para continuar rehabilitación.
Desde ell Dia 10 En Horas De Larde Se Logra Realizar Ventanas Sin Requerimiento De Oxigeno Que Tolera Adecuadamente. En condiciones de lata medica con HODOM Para continura con Kine respiratoria y motora.

PLAN DE MANEJO:

Alta con HODOM
IC Broncopulmonar
TTO MEDICO
Control poli de Medicina

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asisitdo
2. Régimen papilla diabética a tolerancia
3. Bromuro ipratropio 4 puff c/ 8hrs c/AC
4. Prednisona 20 mg/día vo por 5 dias
5. Hidroclorotiazida 25 mg/día vo
6. Amlodipino 10 mg/día vo
7. Slow K 2 comp c/6hrs vo
8. I. NPH 8 U AM - 8 U PM sc
9. Quetiapina 25 mg 1/2 comp AM - 1 comp PM sc
10. Lactulosa 15 cc cada 12 horas vo

EXÁMENES Y RESULTADOS

Exámenes de laboratorio 10.7.24 : Glicemia : 65 Creatinina : 0,90 Clearence Calculado(MDRD) : 60,09 Lactato : 1,6 Proteina C Reactiva : 45,4 Uremia : 60 Sodio (Na) : 138,00 Potasio (K) : 4,00 Cloro (Cl) : 106,00 Procalcitonina : 0,15

Exámenes control 11.7.24 : pH : 7,53 pCO2 : 33,4 mmHg pO2 : 83,3 mmHg HCO3 ACT. : 28,0 mmol/L O2 SAT : 95,0 o/o FiO2 : 21,0

CARABALLO DE HURTADO
JENNIFER DEL CARMEN
MEDICO TRATANTE
26251544-3

JEFE SERVICIO